

monotropism-autism-prevalence-global_pt

Autismo e monotropismo: quão comuns são, na realidade?

Um brief de investigação citado — verificando os números regionais do autismo e a pergunta "que percentagem de pessoas é monotrópica".

Informativo, não conselho médico. Estes números descrevem quantas pessoas são contadas como autistas ou pontuam alto numa escala de monotropismo. A contagem depende muito de quem procura, como e onde. Nada aqui é diagnóstico.

Resumo executivo

- **O autismo não é 1% em todo o lado.** O número global mais limpo é a estimativa do **Global Burden of Disease (GBD) 2021**, agora adotada pela OMS: cerca de **1 em cada 127 pessoas (~0,8%)** estava no espectro do autismo em 2021 [1][2]. Para *crianças*, as revisões agrupadas ainda ficam perto do antigo **~1 em cada 100** [3]. Os Estados Unidos — o país mais intensivamente rastreado — reportam **1 em cada 31 (3,2%)** entre crianças de 8 anos (CDC, dados de 2022) [4].
- **As diferenças regionais são maioritariamente um artefacto de medição, não biologia.** O mesmo estudo GBD encontrou a carga relacionada com o autismo *mais baixa* no Sudeste/Leste Asiático e Oceânia e *mais alta* na super-região de altos rendimentos [1]. Esse padrão segue a infraestrutura de diagnóstico, a consciencialização e o rastreio — não diferenças reais na frequência do autismo.
- **A tabela regional frequentemente citada é substancialmente errada para o Médio Oriente e simplificada em excesso para a**

Ásia. Uma meta-análise de 2025 coloca a prevalência agrupada do Médio Oriente e Norte de África (MENA) em apenas ~0,14% (intervalo 0,01% Omã → 2,51% Arábia Saudita) [6], e uma meta-análise asiática reporta para o Leste Asiático ~0,51% e a China continental ~0,7% [5] [7] — muito abaixo dos "0,9–1,5%" frequentemente alegados para o mundo árabe.

- **O monotropismo não tem uma "prevalência" acordada, e o número "15–20% das pessoas são monotrópicas" é um erro de categoria.** O monotropismo é um estilo cognitivo *dimensional* (uma característica contínua), não um diagnóstico. O único grande estudo empírico — o **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — descobriu que os participantes autistas tiveram em média 4,15/5 e os participantes não-autistas 3,19/5, com sobreposição substancial [10]. Não diz "X% das pessoas são monotrópicas".
 - **A alegação ">90% das pessoas autistas são monotrópicas" é uma declaração teórica sobre quão bem a teoria captura a experiência autista, não uma percentagem medida.** É defensável como *validade subjetiva*, enganosa como *epidemiologia*.
-

1. Quantas pessoas são autistas? (e porque existem dois números de destaque)

Dois números circulam, e respondem a perguntas ligeiramente diferentes:

- **~1 em cada 100 crianças.** Este é o número agrupado através de dezenas de estudos em revisões sistemáticas (ex. Zeidan et al., 2022) e é o resumo de longa data *focado em crianças* da OMS [3]. Reflete estudos que rastreiam maioritariamente populações pediátricas.
- **1 em cada 127 pessoas (~0,79%), todas as idades.** Esta é a estimativa modelada do **GBD 2021** — 61,8 milhões de pessoas em 2021 — que a OMS adotou agora palavra por palavra ("Em 2021 cerca de 1 em cada 127 pessoas tinha autismo") [1][2]. É mais baixa per capita porque abrange toda a vida, incluindo gerações mais velhas que nunca foram rastreadas.

A diferença entre "1 em cada 100" e "1 em cada 127" não é uma contradição: o primeiro são crianças, o segundo toda a gente. Ambos são defensáveis se a população for declarada.

O GBD também dá uma clara divisão por sexo — cerca de **1,06% dos homens** versus **0,51% das mulheres** (1.064,7 vs 508,1 por 100.000) — refletindo a subidentificação bem documentada de raparigas e mulheres autistas, não uma diferença biológica de dobro [1].

2. Porque é que os números regionais diferem (as diferenças medem maioritariamente *deteção*, não *biologia*)

Este é o ponto mais importante ao ler qualquer tabela regional. Os autores do GBD 2021 descobriram que a carga de saúde relacionada com o autismo variava de **126,5 anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs) por 100.000** na super-região Sudeste Asiático / Leste Asiático / Oceânia até **204,1 por 100.000** na super-região de altos rendimentos [1]. Em termos simples: as partes mais ricas e mais rastreadas do mundo *encontram* muito mais autismo do que o resto.

Os impulsionadores da diferença são quase inteiramente metodológicos e sociais:

- **Infraestrutura de diagnóstico** — redes de vigilância ativa (ex. o ADDM dos CDC dos EUA) procuram casos sistematicamente em escolas e clínicas; muitos países não têm tal sistema e dependem de registos clínicos passivos.
- **Crítérios e consciencialização** — a mudança do restrito "transtorno autista" (DSM-IV) para o espectro de autismo mais amplo (DSM-5, 2013), mais crescente consciencialização pública e profissional, aumentou continuamente a prevalência *identificada* em países que voltam a rastrear.
- **Estigma, idioma e acesso a serviços** — em muitas regiões o autismo é sub-reportado porque as famílias enfrentam estigma, os serviços estão ausentes, ou as ferramentas de rastreio não são validadas no idioma e cultura locais.

Assim, quando uma tabela mostra "0,1% na região X e 3% na região Y", leia como *"a região Y procura mais intensamente e tem mais capacidade de diagnosticar"*, não *"o autismo é trinta vezes mais raro na região X"*. Os autores do GBD enfatizam exatamente isto: é necessária uma melhor cobertura global de dados antes que a variação geográfica possa ser interpretada com confiança [1].

3. Uma tabela regional corrigida

Os números que motivaram este brief são aqui reproduzidos face à melhor evidência disponível. As colunas "Melhor estimativa" citam revisões sistemáticas primárias ou o modelo GBD — não números de advocacy.

Região	Número frequentemente citado	O que a evidência apoia	Fonte
Mundo — todas as idades	"1%"	1 em cada 127 (~0,79%) em 2021 (GBD; agora o número da OMS)	[1][2]
Mundo — crianças	"1 em cada 100"	~1 em cada 100 crianças (revisões agrupadas)	[3]
América do Norte	"1–3,2%"	3,2% (1 em cada 31) crianças americanas de 8 anos (2022, CDC ADDM); ~1 em cada 45 adultos	[4]
Europa	"0,7–1%"	Estudos baseados em registos agrupam-se em torno de ~1% (ex. Dinamarca, Finlândia, Islândia); estimativas populacionais um pouco mais altas	[3]
Médio Oriente e Norte de África	"0,9–1,5%"	Agrupado ~ 0,14% (IC 95% 0,02–0,36%); intervalo por país 0,01% (Omã) → 2,51% (Arábia Saudita)	[6]
Leste / Sudeste Asiático	"0,4–1,4%"	Meta-análise asiática: Leste Asiático ~ 0,51% , Sul da Ásia ~0,31%, Oeste da Ásia ~0,35%; China continental ~ 0,7% (1 em cada 143) ; bolsões fortemente rastreados (Singapura, Japão, Coreia do S.) reportam mais	[5][7]

Duas conclusões da tabela:

1. Os intervalos **norte-americano** e **européu** estão amplamente certos — estas são as regiões mais rastreadas, por isso os seus números altos são esperados.
2. O número **MENA** é o grande erro. Uma prevalência agrupada perto de **0,14%** quase certamente reflete *subdiagnóstico e vigilância fraca*, não um autismo genuinamente mais raro. A enorme dispersão intra-região (Omã 0,01% a Arábia Saudita 2,51%) é ela mesma o sinal: a verdadeira biologia não varia tanto entre países vizinhos; a vigilância sim [6].

4. O autismo está realmente "a aumentar"?

A prevalência de destaque subiu acentuadamente — nos EUA de cerca de 1 em cada 150 (2000) para 1 em cada 31 (2022) [4]. A explicação dominante entre os epidemiologistas é **melhor e mais ampla identificação**, não necessariamente mais autismo:

- critérios alargados (DSM-IV → DSM-5),
- procura ativa de casos (vigilância do tipo ADDM),
- rastreio mais precoce e equitativo entre sexo, raça e etnia,
- estigma reduzido levando a mais avaliações.

Os autores do GBD notam que a prevalência tem sido comparativamente *estável* onde a qualidade dos dados é controlada, e que os "aumentos" aparentes acompanham maioritariamente a capacidade de deteção [1]. O resumo honesto: **estamos cada vez mais a contar um autismo que sempre esteve lá.**

5. Quantas pessoas são "monotrópicas"? (a pergunta que não tem uma única resposta)

O monotropismo (Murray, Lawson & Lesser, 2005) é um relato do autismo *baseado na atenção*: uma mente monotrópica concentra os seus recursos em poucos "túneis de atenção" intensamente ativados, em vez de espalhar a atenção por muitos canais (polytropismo). Crucialmente, é enquadrado como uma **diferença na alocação da atenção, não um défice** — e como um **espectro**, não uma categoria sim/não.

Por causa disso, não há **prevalência acordada de "monotropismo"**, por três razões estruturais:

1. **Não é um diagnóstico.** O monotropismo não aparece em nenhum lado no DSM-5 ou CID-11. Não há registo de casos nem limiar de diagnóstico.
2. **É dimensional, não categórico.** Toda a gente pode entrar num estado de "fluxo" focado; a diferença autista é que o foco profundo e estreito é o *modo de operação padrão* em vez de um estado ocasional. Uma linha entre "monotrópico" e "polytrópico" seria arbitrária.
3. **O instrumento reporta médias, não casos.** O instrumento validado — o **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — produz uma pontuação contínua de 1 a 5, e os investigadores comparam *médias de grupo*, não "quantas pessoas excedem um ponto de corte" [10].

Os números reais que temos (estudo de validação do MQ)

No estudo de desenvolvimento do MQ (1.110 participantes: 756 autistas, 354 não-autistas) [10]:

- **Participantes autistas: média 4,15 / 5 (DP 0,347)**
- **Participantes não-autistas: média 3,19 / 5 (DP 0,578)**
- **Estatuto de TDAH** previu independentemente pontuações de monotropismo mais altas (relevante porque o autismo e o TDAH co-ocorrem em cerca de 30–80% dos casos dependendo da direção).
- Uma análise fatorial exploratória produziu uma **estrutura de 8 fatores** (interesses especiais; ruminação/ansiedade; necessidade de rotinas; ambiente e o túnel de atenção; perder o rasto do ambiente; tomada de decisão; efeito redutor de ansiedade dos interesses; gerir interações sociais).

A sobreposição entre as duas distribuições é substancial — muitos não-autistas pontuam acima de alguns autistas, e vice-versa. Essa sobreposição é *exatamente* porque uma manchete "X% da população é monotrópica" não é significativa sem um ponto de corte arbitrário (e contestado).

6. De onde vêm os números ">90%" e "15–20%" — e porque não são dados de prevalência

Estes dois números, que circulam amplamente online, merecem uma verificação direta.

">90% das pessoas autistas são monotrópicas." Isto lê-se melhor como uma alegação sobre **validade subjetiva** — isto é, *quando pessoas autistas encontram o enquadramento do monotropismo, uma esmagadora maioria reconhece-o como uma descrição precisa da sua experiência*. Isso é um fenómeno real e significativo (o MQ foi construído *com* um grupo comunitário liderado por autistas precisamente porque a descrição ressoava [10]). Mas **não é uma prevalência epidemiológica**; nenhum estudo calculou "a proporção de pessoas autistas que são monotrópicas" contra um limiar validado, porque não há um limiar acordado. Enunciado como *"o monotropismo tem uma validade subjetiva muito alta para pessoas autistas"*, é defensável; enunciado como *"mais de 90% das pessoas autistas são monotrópicas"*, sobrestima o que foi medido.

"15–20% da população em geral é monotrópica." Este número é quase certamente uma **confusão com "neurodivergência"**. Estimativas comunitárias colocam *alguma forma* de neurodivergência (TDAH, dislexia, dispraxia, síndrome de Tourette, etc., com forte sobreposição) na ordem dos 15–20% da população. Para contexto, mesmo os componentes melhor medidos são muito menores isoladamente: o TDAH em adultos afeta cerca de **2,58%** (persistente) a **6,76%** (sintomático) dos adultos globalmente [8], e o TDAH infantil é frequentemente estimado em torno de 5–8%. A dislexia é frequentemente citada perto dos ~10% dependendo da definição. **Nenhum destes é um número de monotropismo**. Igualar "neurodivergente" a "monotrópico" é um erro de categoria: o monotropismo é uma *dimensão* de estilo cognitivo que está elevada em — mas não é idêntica a — vários perfis neurodivergentes. Atualmente **não há um número baseado em evidência** para a prevalência de monotropismo na população em geral.

Conclusão sobre o monotropismo: trate-o como uma tendência mensurável num espectro, fortemente (mas não exclusivamente) associada ao autismo e ao TDAH, com alta validade de experiência vivida para pessoas autistas. A resposta honesta a "que percentagem de pessoas é monotrópica?" é: esta ainda não é uma pergunta bem definida, e qualquer percentagem precisa que veja foi inventada.

7. Conclusões práticas

- **Cite o número que corresponde à população.** "1 em cada 127 pessoas" (todas as idades, GBD/OMS) e "~1 em cada 100 crianças" estão ambos corretos — diga qual quer dizer [1][2][3].
- **Trate as diferenças regionais como diferenças de detecção.** A baixa prevalência reportada na MENA, em partes da Ásia, e entre raparigas/mulheres, adultos mais velhos e grupos racializados reflete subidentificação, não ausência [1][6].
- **Não apresente o monotropismo como tendo uma prevalência.** Reporte médias do MQ e o enquadramento dimensional; evite ">90%" e "15–20%" como declarações de prevalência [10].
- **Mantenha o enquadramento neuroafirmativo.** A maior identificação de autismo em países bem equipados é um sucesso de consciencialização e acesso; monotrópico versus polytrópico é uma diferença de atenção, não um défice — consistente com como os criadores e a comunidade autista enquadraram a teoria.

Fontes

[1] Global Burden of Disease Study 2021 Autism Spectrum Collaborators (2024). *The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the Global Burden of Disease Study 2021*. The Lancet Psychiatry (19 dez. 2024). doi:10.1016/S2215-0366(24)00363-8 — 61,8M de pessoas (1 em cada 127) em 2021; prevalência padronizada por idade 788,3/100.000 (homens 1.064,7; mulheres 508,1); DALYs super-regionais 126,5 (SE/Ásia Oriental e Oceânia) a 204,1 (altos rendimentos) por 100.000. <https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215->

0366(24)00363-8/fulltext · IHME: <https://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-epidemiology-and-health-burden-autism-spectrum-findings-global>

[2] Organização Mundial de Saúde (2024). *Autism fact sheet (key facts)*. — "In 2021 about 1 in 127 persons had autism." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

[3] Zeidan, J. et al. (2022). *Global prevalence of autism: A systematic review update*. Autism Research (Wiley). doi:10.1002/aur.2696 — ~1 em cada 100 crianças; dados de registos europeus (França, Dinamarca, Finlândia, Islândia). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696>

[4] CDC, Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network (2025). *Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022*. MMWR, 74(SS-2). — 1 em cada 31 (3,2%) entre crianças de 8 anos. Relatório comunitário: <https://www.cdc.gov/autism/media/pdfs/2025/04/ADDM-Community-Report-SY2022.pdf> · MMWR: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm>

[5] Lu, Y. et al. (2020). *Prevalence of autism spectrum disorder in Asia: a systematic review and meta-analysis*. Psychiatry Research, 284, 112679. doi:10.1016/j.psychres.2019.112679 (PMID 31735373) — Leste da Ásia 0,51%, Sul da Ásia 0,31%, Oeste da Ásia 0,35%. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735373>

[6] Abdallah, B.M. et al. (2025). *Estimates of the prevalence of autism spectrum disorder in the Middle East and North Africa region: a systematic review and meta-analysis*. BMC Public Health, 25:2519. doi:10.1186/s12889-025-23651-x (PMID 40691829) — agrupado 0,14% (IC 95% 0,02–0,36%); intervalo por país 0,01% (Omã) a 2,51% (Arábia Saudita). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40691829>

[7] Jiang, X. et al. (2024). *Prevalence of autism spectrum disorder in mainland China over the past 6 years: a systematic review and meta-analysis*. BMC Psychiatry (PMID 38811881) — ~0,7% desde 2017 (~1 em cada 143). Corroborado por uma revisão de exploração de políticas (SAGE) de 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38811881>

- [8] Song, P. et al. (2021). *The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a global systematic review and meta-analysis*. General Psychiatry / PMC7916320 — TDAH adulto persistente 2,58%; sintomático 6,76%. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7916320>
- [9] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156. doi:10.1177/1362361305051398 — origem da teoria do monotropismo. <https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [10] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (medida de auto-relato de 47 itens; preprint de validação). Open Science Framework. — n = 1.110 (756 autistas, 354 não-autistas); média autistas 4,15 (DP 0,347) vs não-autistas 3,19 (DP 0,578) numa escala 1–5; TDAH previu independentemente pontuações mais altas; estrutura de 8 fatores. Ficheiro do questionário: <https://osf.io/wpx5g> · preprint de validação: <https://osf.io/ft73y> · licença: CC BY-NC-SA 4.0. Arquivo local: `sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf`